K

Ambulantní vyšetření kontrolní

Poláček Daniel

MR vyš. mozku 14.9.2026 NNJ
Závěr:
Solitérní nodulus postkontrastně se sytící v pravé mozečkové hemisféře(do 3mm) - suspekce na solitérní MTS, postkontrastně bez jiných, sytících se lézí intrakraniálně.
Gliózy supratentoriálně Fazekas gr. III.

Diagnózy: C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku

Závěr:

RCC lok. pokročilý diag. 4/2022
- 2.6.2022 - stp. transperitoneální nefrektomii vpravo s retroperitoneální lymfadenektomií
Histol. světlobuněčný renální adenokarcinom G2, pT2a pN1(3+/5) M0
- HBsAg pozit. pac.
- CT hrudník + břicho s KL 7.9.2022 - susp. MTS paraaortální uzlina vlevo 20mm - st.p. exstirpaci paraaortální LU vlevo 25.10.2022
Histol. MTS světlobuněčného renálního karcinomu G2, R0
- CT břicha, malé pánve nativně a kontrastně 25.11.2022 susp. lymfokéla po lymfadenektomii spíše ohraničená kolekce tekutiny do 36 mm vlevo paraaortálně v úrovni L2-3 než nová zvětšená uzlina.
- baseline CT s KL 6.3.2023 patol. mediastinální a pl. hilová lymfadenopatie - jsou hypervaskularizované mts charakteru

Dle IMDC střední prognóza - 1 faktor - interval méně než 1 rok od diagnózy do započetí syst. léčby.

- 27.3.2023 1. cyklus nivolumab 3mg/kg + ipilimumab 1mg/kg q3w
- 17.4.2023 2. cyklus -//-
= po 2. cyklu rozvoj GIT toxicity 1.st., plicní toxicita = IPP 1.až 2. stupně, od 28.4.2023 kortikoterapie prednison 1mg/kg/den s rychlou a výraznou regresí plicního nálezu

Restaging. CT 6/2023 + 11/2023 + 2/2024 + 6/2024 + 10/2024 + 2/2025 + 6/2025 iPR 11/2025 dle iRECIST PD (progressive disease) - nově patol. LU v levém plic hilu

= udržovací léčba nivolumab od 27.6.2023 do 29.12.2025

- 11/2025 dle iRECIST iUPD - nově patol. LU v levém plic hilu
- 1/2026 iCPD - v levém hilu je velikostní progrese uzlin od baseline i ve srovnání s minulým CT, další progrese jedné LU retroperitonea (na baseline neměla char. T-léze)

- 2. pal. linie léčby sunitinib - start 27.1.2026
- při dávce 50mg denně progrese renální insuf., minerálová dysbalance a trombocytopenie G2-3
- od 25.2.2026 redukce o 1 stupeň - dávka 37,5mg denně - hepatopatie G2
- od 26.3.2026 redukce o 2 stupně - dávka 25mg denně
- restaging. CT 4/2026 - SD
- restaging. CT 8/2026 - PD

- 3. pal. linie léčby everolimus - start 3.9.2026

Implantace venozního portu 21.8.2023
Typ: Medcomp power-port, vysokoprůtokový (5ml/s) 6,6fr., kompatibilní s CT a MR.

- 21.11.2023 excize susp. iritovaného intraderm. névu brady vlevo
Histol. kožní metastáza světlebuněčného (konvenčního) karcinomu renálního origa v oblasti brady vlevo, grade 2 dle ISUP, odstraněná kompletně
- kožní leze v oblasti glabely - stp. excizi 11.2.2025,
histol. sebaceom, kompletně odstraněn, kůže se solární elastózou, bez nádorových změn.

3

Ambulantní vyšetření kontrolní

Ošetření, léčba:

OA: HN, CHOPN u fumátora (anamn. léčba přerušena pacientem), HLP na dietě, hyperglykémie nalačno anam., korové cysty ledvin, cysta S2 jater

Everolimus sandoz 5mg 1-0-0 zvyšuji na 2-0-0 od 19.9.2026, pokud by tuto dávku netoleroval, vrátí se k původnímu užívání 1-0-0

Tablety užívat jednou denně, vždy ve stejnou denní dobu, důsledně buď vždy s jídlem, nebo vždy bez jídla. Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. Tablety se nesmí kousat nebo drtit.

Nesmí se současně jíst grepy, pomelo, grepové džusy, preparáty s třezalkou. Nené vhodné současné užívání antimykotik a antivirotik p.o. nebo i.v. (lokální aplikce nevadí), verapamilu, erytromycynu, klaritromycinu. Kontraindikovány jsou ACEi pro zvýšené riziko anafylace.

Při nevolnosti doma užívat Degan 10mg tbl. 1-1-1, při nedostatečném efektu nebo zvracení přidá Novetron 8mg tbl. 1-0-1 á 12hod.
Při průjmu užívat Imodium 2mg cps., vstupně 2 cps., pak 1 cps. při každé další řídké stolici, maxim. 8 cps. denně. Při nedostatečném efektu přidá Smecta 1-1-1.

Chron. medikace: Kapidin 20mg 1-0-0, Spiriva inhal. 1-0-1 + Ventolin N inhal. dlp.
Při úzkosti, neklidu Neurol 0,25mg 1tbl. dlp.
Cps. Natrii chloridi 1,0g 1-0-1, pro hypokalcémii Calcichew 1000/800IU 0-0-1.

Pro mírnou hyperkalémii ve stravě omezit banány, meruňky, broskve, sušené a kompotované ovoce, džusy, čokoládu, kakao, černý čaj - poučen.

Doporučení:

Pacient po nefrektomii vpravo a retroperitoneální lymfadenektomii pro tumor 6/2022, histol. světlobuněčný renální adenoca G2, vstupně bez zn. generalizace. Při restagingu 9/2022 zjištěna susp. paraaortální uzlina vlevo, stp. extirpaci 10/2022 - histol. mts světlobuněčného renálního ca. Další restaging. 3/2022, kde patol. mediastinální a plicní hilová lymfadenopatie charakteru hypervaskularizovaných mts. Dle IMDC střední prognóza - 1 faktor - interval méně než 1 rok od diagnózy do započetí syst. léčby.
Je indikováno podání nivolumab 3mg/kg v kombinaci s ipilimumabem 1mg/kg q3w 4 cykly - schváleno KOC komisi.
Po podání 2 cyklů léčby rozvoj GIT toxicity 1.st., plicní toxicita = IPP 1.až 2. stupně, od 28.4.2023 kortikoterapie prednison 1mg/kg/den s rychlou regresí plicního nálezu. Proto od 12.5.2023 zahájeno postupné snižování dávky kortikoidu, ukončen 26.7.2023.
Dle restaging. CT 6/2023 dosaženo iPR, proto pokračujeme v udržovací léčbě nivolumabem 240mg q2w.
Při CT vyš. 9/23 popisován nově útvar do 21x27 mm vlevo ventrálně v mesogastriu, etiologie je spíše cystická, jinak bez lymfadenopatie, bez mts, restaging. CT vyš. 11/2023 + 2/2024 + 6/2024 + 10/2024 + 2/2025 + 6/2025 - trvá iPR - pokračujeme v zavedené léčbě.

11/2023 provedena excize susp. ložiska na bradě vlevo, histol. kožní metastáza světlebuněčného (konvenčního) karcinomu renálního origa, grade 2 - dle pacienta pozoruje cca od 6/23, dle CT vyš. 11/23 iPR.

Opakovaným CT vyš. 11/2025 a 1/2026 verifikována progrese onkologického onemocnění.
Do 2. linie léčby indikován sunitinib 50mg denně = schváleno KOC komisí.
Léčbu zahájil od 27.1.2026 v režimu 4/2.
Dle restaging. CT 4/2026 SD - velikostní regrese sledovaných lézí je o cca 24 %.

Dle CT 8/2026 ale PD - velikostní progrese LU v levém pl. hilu a v retroperitonu paraaortálně vlevo. Proto léčbu sunitinibem ukončuji.

Do 3. pal. linie léčby indikován everolimus - schváleno KOC komisí. Cabozantinib na

par. 16 ponecháme do 4. linie.

Tolerance léčby vývorná, lab., vyš. bez zásadní patologie, proto navyšuji Everolimus na 10mg denně.

Nález při MR vyš. mozku zadávám k projednání na NCH semináři.

Kontrola zde 9.10.2026 s odběrem KO, biochemie.
Provádět domácí měření TK. Při dobré toleranci navýšíme everolimus na 10mg denně.
Při obtížích kontrola zde ihned, mimo ordinační hodiny na interní amb. NNJ.

Kontrola v plicní amb.
Kontrolní CT H+B+MP bude v 9.20hod. nalačno v NNJ.
Kontrolní kolonoskopie bude r.2028.

Poznámka: Pacient/zákonný zástupce poučen o povaze onemocnění a léčbě, rozumí a souhlasí. Při odchodu je pacient ve stabilizovaném stavu.

Tuto zprávu a Vaši další dokumentaci ze zarızení skupiny AGEL naleznete ve svém profilu MůjAGEL na stráce muj.agel.cz - nemáte ještě profil? Požádejte o přístup svého lékaře či sestru!

~~Stav materiálu:~~
S_IDXLIPK: NEGAT -, S_IDXHEMK: NEGAT - S_IDXIKTK: NEGAT - UNSF_OTHER: sérum
Sérum, plazma - zánět:
S_HSCRP: **9,5** mg/l [0 ... 5]
Sérum, plazma - sacharidy:
S_GLC: **6,7** mmol/l [3.9 ... 5.6]
Sérum, plazma - další vyš.:
S_BIL: 4,2 µmol/l [0 ... 21]
Sérum, plazma - dusik.metab.:
S_UREA: 7,0 mmol/l [2.9 ... 8.2], S_CREAE: **107** µmol/l [59 ... 104], S_URAT: 301 µmol/l [202 ... 417]
Sérum, plazma - enzymy:
S_ALT: 0,48 µkat/l [0.17 ... 0.84], S_AST: 0,58 µkat/l [0.17 ... 0.84], S_ALP: 1,30 µkat/l [0.67 ... 2.15], S_GGT: 0,40 µkat/l [0.17 ... 1.19]
Krev - minerály, kovy:
S_NA: 140 mmol/l [136 ... 145], S_K: 4,97 mmol/l [3.5 ... 5.1], S_CA: 2,24 mmol/l [2.2 ... 2.55], S_CL: 106 mmol/l [98 ... 107], S_OSMOLC: 294 mmol/kg [275 ... 295]
Renální funkce:
PT(KIDN)_EGFRCKDE: **1,01** ml/s/1,73 m2 [1.5 ... 99]
Krevní obraz:
B_LKC: 6,58 10^9/l [4 ... 10], B_ERC: **3,53** 10^12/l [4 ... 5.8], B_HB: **123** g/l [135 ... 175], B_HCT: **0,363** 1 [0.4 ... 0.5], ERC(B)_MCV: **102,8** fl [82 ... 98], ERC(B)_MCH: **34,8** pg [28 ... 34], ERC(B)_MCHC: 339 g/l [320 ... 360], B_RDW: 13,5 % [10 ... 15.2], B_PLT: 156 10^9/l [150 ... 400], B_PCDW: 0,0016 1 [0.0012 ... 0.0035], PLT(B)_MPV: 10,3 fl [7.8 ... 12.8], B_PDWSD: 10,7 fl [9 ... 17], LKC(B)_NEU: 0,627 1 [0.45 ... 0.7], LKC(B)_LYMFO: 0,245 1 [0.2 ... 0.45], LKC(B)_MONO: 0,114 1 [0.02 ... 0.12], LKC(B)_EOS: 0,012 1 [0 ... 0.05], LKC(B)_BAS: 0,002 1 [0 ... 0.02], B_NEU: 4,130 10^9/l [2 ... 7], B_LYMFO: 1,610 10^9/l [0.8 ... 4], B_MONO: 0,750 10^9/l [0.08 ... 1.2], B_EOS: 0,080 10^9/l [0 ... 0.5], B_BAS: 0,010 10^9/l [0 ... 0.2], B_NLR: 2,6 1 [0 ... 4]
Primární vzorek (druh):
KREV: dodáno

Ambulantní vyšetření kontrolní

Subj. nově předepsaný everolimus toleruje výbormně, nemá s ním žádný problém. nechutenství není, nevolnoist také ne, nezvrací, průjem neguje.
Na cílený dotaz neguje závratě či poruchy rovnováhy, jenom jsou někdy během dne mžitky před očima.
nyní si TK neměřil, protože byl na dovolené.

Objektivní nález: Tlak S/D [mmHg]: 155/70, Pulz [1/min]: 68, Dech [1/min]: 14, Hmotnost [kg]: 87, Výška [cm]: 183, BMI: 25.98, Plocha těla [m2]: 2.09

Status praesens: ECOG PS: 1, bez klin. známek mozkových mts
lucidní, orientace správná, spolupracuje, eupnoe, bez cyanózy, bez ikteru, normální hydratace
HLAVA: poklep nebolestivý, zornice izokorické, správně reagují na osvit, hrdlo zarudlé, hnisavý povlak, tonzily nezvětšené, jazyk vlhký, bez povlaku, plazí středem
KRK: souměrný, šíje bez opozice, štítnice nezvětšená, uzliny nehmatné, pulzace karotid symetrická, bez šelestu, žíly bez kongesce.
HRUDNÍK: souměrný, palpačně nebolestivý, prsy bez patologického nálezu, axily, nadklíčky volné, bez LU, páteř poklepově nebolestivá.
PLÍCE: poklep plný, jasný, dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenu.
SRDCE: akce pravidelná, ozvy ohraničené, bez šelestu.
BŘICHO: v niveau, měkké, prohmatné, palpačně nebolestivé, bez patologické rezistence, peristaltika přiměřená, játra v oblouku., slezina nenaráží, tapott bilaterálně negativní,
Zevní genitál: nevyšetřen
VYŠETŘENÍ PER RECTUM: nevyšetřen
KONČETINY: hybnost v normě, klouby bez deformit.
DKK: třísla bez hmatných zvětšených LU, bez otoků, varixů a flebitid, pulzace hmatné symetricky do periferie.
ST.LOC . . : jizvy pod pravým i levým obloukem žeberním klidné.

Provedená vyšetření: **Plicní vyš.**
Spirometrie - lehká obsturce
CHOPN II/B fumat, inhal teprie Spiriva rest 2-0-0 + Ventolin dlp, kontrola za 1/2 roku

CT plic + břicha 10.11.2025
Závěr:
ve srovnání s base line CT z 03/2023 trvá mírná parc. regrese velikosti retroperitoneální lymfadenopatie vlevo (ve srovnání s min. CT z 06/2025 je ale mírná progrese velikosti), navíc nově patol. LU v levém plicním hilu - dle **iRECIST tedy PD (progressive disease).**

CT hrudník, břicho 16.1.2026
Závěr:
Ve srovnání s baseline CT došlo k regresi mediastinální a pravostranné hilové lymfadenopatie, v levém hilu je velikostní progrese uzlin od baseline i ve srovnání s minulým CT. Další progrese jedné LU retroperitonea (na baseline neměla char. T-léze), jiná LU zas v regresi. Dle iRECIST iCPD.

Dle iRECIST	dnes	baseline 3/2023
T-léze		
LU pravého pl. hilu	6	22
LU retroperitonea	11	33
ložisko před L ledvinou	0	20
Nové léze		
LU levého pl. hilu	15 (minule 10)	8
LU retroperitonea	36 (minule 34)	9
Non-T léze		

LU mediastina a hilů 10-15 mm	ano v L hilu	ano

CT Ag plicnice 10.2.2026
Závěr: Bez plicní embolie, jen drobná cysta v HL vpravo.
Drobné osteoplatické ložiska do průměru 7mm v přechodu th/L páteře.

Interní vyš. 10.2.2026 NNJ
Závěr: Dušnost k vyloučení kard. etiologie
Doporučení:
- plicní embolie vyloučena, EKG bez ischemických změn, hstroponin stabilní bez dynamiky- možno na vrub dekorigované HT
- u nás kontrolní TK 174/92, dle pacienta doma prav. TK kolem 150
- nově k medikaci Orcal 10 mg tbl 1/2-0-0, doma prav. měřit tenze -poučen, zapisovat a hodnoty donést ke shlédnutí k PL

ECHO 20.2.2026 NNJ
Zavěr:
Normální velikosti srdečních oddílů. Normální systol. fce LK s EF 60%, bez hrubších regionálních poruch kinetiky při suboptm. přehlednosti, bez hypertrofie. Dobrá fce PK.
Ao chl: okrajově skleortická, 3-cp, dobře separuje, bez reg, PG 11 mmHg
Mi chl: jemná, dobře pohyblivé cípy, stop. reg
Tr chl: jemná, bez zřetelné reg
PU chl: jemná, typ křivky II v RVOT, stop. reg
perikard bpn, asc. ao bez dilatace
RES: dobrá systolická funkce obou komor, bez hemodynamicky významné chlop. vady

CT hrudník, břicho 28.4.2026

Dle iRECIST	baseline 1/26	dnes
T-léze		
LU pravého pl. hilu	6	6
ložisko před L ledvinou	0	0
LU levého pl. hilu	15	12
LU retroperitonea	36	30
Non-T léze		
LU mediastina a hilů 10-15 mm	ano v L hilu	ano

Závěr:
~~Ve srovnání~~ s baseline CT 1/2026 došlo k mírné regresi velikosti LU v levém plicním hilu, jinak v mediastinu a pravém hilu další LU stacionární.
Parc. regrese velikosti patologické LU v retroperitoneu.
Nová ložiska nepřibyla.
Velikostní regrese sledovaných lézí je o cca 24 %.
Dle iRECIST = iSD.

Plicní vyš. 22.5.2026 MUDr.Hofrová
Spirometrie - lehká obstrukce
Z: CHOPN II/B fumat., susp. interstic. postižené, stp. kortikoterapii
Dop. inhal Spiriva resp. 2-0-0 + Ventolin dlp., Erdomed 300mg 1-1-0, kontrola 9/2026 + spirometrie

UZ tepen DKK 30.7.2026
RE: Na tepnách DKK středně silné sklerotické (ne angiitické) změny.
Dopplerometrický nález je vlevo negativní a velmi dobrý. Vpravo zřetelná, i když ne těžká stenosa v prox. úseku PDK. Sledování vhodné.

CT hrudník, břicho, malá pánev 26.8.2026
Závěr:
~~Ve srovnání~~ s minulým CT z 4/2026 i s baseline CT z 1/2026 je patrná velikostní progrse LU v levém pl. hilu a v retroperitonu paraaortálně vlevo.